Standardiserad vårdprocess bipolär sjukdom

Processansvariga:
Sven Rydhög
Robin Åkerlund

Datum: 2022-05-30

Vårdplan 4
Närståendes delaktighet i vård och behandling 4
Barn som anhöriga 4
Transkulturella aspekter 5
Exempelfrågor till förintervju 5
Trauma 6
Patientinformation 6
Bedömning 6
Screening 7
Nivå 1 7
Nivå 2 9
Nivå 3 9
Diagnosspecifik patientinformation 10
Behandling 10
Vårdplan 10
Episodförebyggande åtgärder 10
Behandling vid pågående manisk eller hypomanisk episod 17
Behandling vid pågående depressiv episod 20
Behandling vid pågående blandad episod 23
Rehabilitering/återhämtning/samverkan 25
Nivå 1 26
Nivå 2 26
Nivå 3 26
Uppföljning och utvärdering 27
Nivå 1 27

Nivå 2 27
Nivå 3 28
Att beakta 29
Referenser 30
Bilaga 1. Patientinformation 32
Bilaga 2. Litiumbehandling 36

Vårdplan

Vårdplan ska upprättas så snart som möjligt men senast vid tredje besöket. Vårdplanen ska kontinuerligt följas upp i samband med uppföljning och utvärdering. I vissa fall ska även en kris-/säkerhetsplan upprättas som beskriver vad som ska göras om patientens mående försämras.

Närståendes delaktighet i vård och behandling

Som medarbetare i vården bör du alltid uppmuntra patienten att involvera närstående i sin vård och behandling. Närstående är ofta en naturlig del i patientens behandlings- och återhämtningsprocess. Det är dock patienten själv som bestämmer om närstående ska göras delaktiga. Patienten bestämmer också om närstående ska få veta att hen är inlagd på en vårdavdelning, och vilken behandling patienten får.

Närstående till en patient som vårdas enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) har rätt att få svar på frågan om personen vårdas med stöd av sluten psykiatrisk tvångsvård. Information om hälsotillståndet och vården lämnas bara ut om patienten har lämnat samtycke till det.

Närstående till en patient som är inlagd på en psykiatrisk eller rättspsykiatrisk vårdavdelning har rätt att få information om:

- Patientens sjukdom och behandlingsmöjligheter.
- Kontaktvägar inom psykiatrin.
- Barnombud för närstående under 18 år.
- Patient- och närståendeföreningar samt utbildningar.

Närstående har också möjlighet att:

- Delta i vårdplaneringar, läkarsamtal och andra planerade möten.
- Få råd och stöd från psykiatrin.
- Få familj-/närståendestöd.

Barn som anhöriga

Enligt HSL kap. 5 § 7 ska hälso- och sjukvården uppmärksamma minderåriga barn som anhöriga och deras behov av information, råd och stöd. Enligt SoL kap. 14 § 1 har vi anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.

Även barn som inte misstänks fara illa i sin hemmiljö har ofta behov av insatser som hjälper familjen att hantera påfrestningar som psykisk sjukdom innebär. Sådan psykosocial intervention bör ges av alla medarbetare. Vid behov av konsultation kontakta din verksamhets barnombud som har särskild träning och utbildning inom detta område.

I arbetet med barn som anhöriga används dokumenten:

- Handlingsprogram barn som anhöriga
- Handlingsprogram vid misstanke om barn som far illa

Vid samtal om den minderåriges situation, behov och möjlighet till stöd, ska du dokumentera KVÅ-kod för att kunna följa upp.

- DU055 med vuxen
- DU056 med vuxen och barn
- DU057 med barn utan vuxen
- GD008 anmälan SoL

Vid behandling av patienter vid graviditet eller med spädbarn bör behov av samverkan med Bup (späd- och småbarnsverksamhet), specialistmödravård och barnhälsovård bedömas.

- Oro för väntat barn
- När det finns minderåriga barn och ungdomar i familjen

Transkulturella aspekter

Bedömning av kognitiv funktionsnivå kan vara svår att göra med sedvanlig testning. Vissa ickeverbala testmetoder (t.ex. SON-R 6-40 Non-Verbal Intelligence Test eller Leiter-3), arbetsterapeutisk funktionsbedömning och intervju med personer som känner patienten över tid kan bidra med information. Exakt nivåbedömning går ibland inte att göra.

EXEMPELFRÅGOR TILL FÖRINTERVJU

Tänk på att ställa öppna frågor och att anpassa frågorna efter patientens förutsättningar. Frågor vid förintervju kan innefatta:

- Ursprungsland (peka ut på digital karta). Landsbygd eller stad har stor betydelse gällande socioekonomiska förutsättningar, livsvillkor, traditioner, trosuppfattning, syn på funktionsnedsättning med mera.
- Språk/dialekt (vid många språk är de dialektala skillnaderna stora), minoritets-/majoritetsspråk. Fråga patienten innan tolk beställs.
- Livsvillkor under uppväxten, till exempel om det var krig i landet och om uppväxten har kantats av uppbrott
- Tillgång till sjukvård, mat samt lek och fritid under uppväxten.
- Vilken roll patienten hade i familjen under uppväxten.
- Vad andra brukar säga att patienten är bra på.
- Typ av skola/utbildning under uppväxten: ingen alls, hemundervisning eller skola. Omfattning? Läs- och skrivkunnig?
- Digitala kunskaper (till exempel dator, surfplatta, mobil).
- Om flera personer eller samma person stod för omsorgen under uppväxten.
- Hur patienten klarade vardagliga aktiviteter som till exempel planering i sin tidigare omgivning.

- Om patienten flytt från sitt land, undersök hur flykten såg ut. Kartlägg hur lång tid patienten var på flykt, om det fanns tillgång till mat och skydd och om patienten blev utsatt för trauma/hemska händelser.
- Om patienten blivit utsatt för smärta/lidande, psykiskt eller somatiskt.

Det finns även en kulturformuleringsintervju (KFI) enligt DSM-5.

Trauma

Trauma är ingen sjukdom men kan orsaka eller bidra till psykisk sjukdom eller ohälsa såsom depression, ångest, krisreaktion, PTSD, anpassningsstörning, personlighetssyndrom (EIPS) och i mer sällsynta fall psykos.

Ofta leder trauma till övergående besvär som inte behöver behandling i första eller andra linjens psykiatri.

Patientinformation

Att ge information om standardiserade vårdprocesser till patienten underlättar ditt arbete inom vården och ger patienten ökat inflytande och delaktighet i kommande utredning, behandling och rehabilitering som hen även kan följa i vårdplanen.

Patienten bör informeras om att alla patienter får samma patientinformation och att ett av syftena med de standardiserade vårdprocesserna är att säkerställa att patienten ska få en så likvärdig och bra vård som möjligt oavsett var i Skåne patienten söker vård.

Berätta också att vårdprocesserna är framtagna regionalt och att de bygger på den bästa tillgängliga kunskapen för att leda till en så bra effekt som möjligt. Målet är att patienten ska leva ett bra och meningsfullt liv trots eventuella begränsningar som psykisk sjukdom kan innebära. Det kan handla om bedömningsprocessen eller viktiga arbetsprocesser inom akutvården såväl som diagnosspecifika vårdprocesser som till exempel psykos, depression, ångestsyndrom, ätstörning, personlighetssyndrom med flera.

Informera också gärna patienten om var hen kan hitta mer information om de standardiserade vårdprocesserna och diagnosspecifik patientinformation.

- 1177.se
- Film om SVP

Det är även viktigt att informera om att processerna ger stöd för personalen för att ge patienten en så bra och jämlik vård som möjligt utifrån patientens behov.

Bedömning

Bipolär sjukdom utmärks av sin långvariga och episodiska natur. Detta innebär att diagnos kan ställas både under pågående episod och retrospektivt utan pågående symtom. Så korrekt diagnostik som möjligt av bipolär sjukdom är väsentlig för att leda till rätt behandling men

också för att undvika negativa konsekvenser för patienter utan bipolär sjukdom. Det kan handla om långvarig eller livslång läkemedelsbehandling med risk för biverkningar utan någon egentlig medicinsk nytta men även påtvingade eller självvalda restriktioner när det kommer till relationer, familj, arbete och resor.

SCREENING

Minst en misstänkt hypoman eller manisk episod bör vara pågående eller ha förelegat för att bedömning för bipolär sjukdom ska bli aktuell (observera kriterier som rör varaktighet).

MDQ har mycket låg differentialdiagnostisk validitet (framför allt mellan bipolär sjukdom, beroendesjukdom, emotionellt instabilt personlighetssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom) men kan användas med försiktighet som screeningformulär för patienter med återkommande depressioner eller vid depressiva symtom under graviditet och under postpartumperioden.

NIVÅ 1

Aktuellt psykiskt och somatiskt status

Klinikern gör bedömning av grundstämning utifrån observation och intervju.

Följande rutinprover bör tas för att utesluta rubbningar: Na, K, Ca, Krea inklusive eGFR, ALAT, ASAT, GT, ALP, LPK, Hb, TSH, T3 samt T4. Somatisk sjukdom och medicinering bör kartläggas. Relevanta exempel: Hjärtproblem, högt blodtryck, autoimmun sjukdom, astma, njursjukdom, diabetes, epilepsi eller annat neurologiskt problem, sköldkörtelsjukdom, långvarig eller återkommande smärta, allvarlig överkänslighet/allergi, hudproblem, krampanfall, gynekologiska besvär.

AUDIT, DUDIT, B-PEth och urintoxikologisk provtagning rekommenderas inför bedömningssamtalet. Skadligt bruk och beroende av psykoaktiva substanser är mycket vanligt förekommande vid psykiatriska sjukdomar och försvårar både diagnostik och behandling. Maniska/hypomana episoder som är sekundära till intag av alkohol eller narkotika räcker inte för diagnos bipolär sjukdom om inte symtomen kvarstår en längre tid (till exempel en månad) efter att substanseffekten klingat av.

Jämförelse med typisk sjukdomspresentation

Kartlägg debutålder, förlopp, besvärsperioder, tidigare effekt av psykofarmaka, fria intervall och ärftlighet. Ta hjälp av närstående när detta är möjligt. Jämför sedan patientens beskrivning med den typiska sjukdomspresentationen (”prototyp”) för bipolär sjukdom som bland annat kännetecknas av dokumenterad euforisk mani, första episoden vid 15–19 års ålder, fullt friska perioder mellan episoder, tydligt stabiliserande effekt av stämningsstabiliserande läkemedelsbehandling samt minst en dokumenterad förstagradssläkting med bipolär sjukdom (se även Adler 2011, 2014).

Symtombild under typiska besvärsperioder

Genomför retrospektiv kriteriebaserad strukturerad diagnostisk intervju (i första hand senaste versionerna av M.I.N.I. eller SCID) för typiska episoder av mani, hypomani och depression. HCL-32 Klinisk version kan användas som komplement till intervju. Verifiera om möjligt patientens svar av närstående. Uppfylls diagnostiska kriterier för respektive episod?

Bedömning av pågående episod

Genomför när aktuellt diagnostisk bedömning för depressiv, hypoman, manisk eller blandad episod utifrån aktuella versioner av ICD och DSM. Använd när relevant symtomspecifikationer i DSM-5 såsom ångest, blandade drag, psykotiska symtom, katatoni, atypiska symtom, peripartumdebut, täta svängningsperioder och årstidsrelaterat mönster.

Skattningsskalan YMRS (Young Mania Rating Scale) kan vara till hjälp vid bedömning av mani/hypomani. MADRS kan användas både som intervju och självskattning vid bedömning av depressiv episod.

Noggrann suicidriskbedömning enligt aktuella riktlinjer måste alltid göras. Agitation och stark ångest är förenat med särskilt hög suicidrisk liksom depressiva vanföreställningar. Stark ångest kan även finnas bakom en hämmad fasad. Blandad episod innebär en särskilt förhöjd suicidrisk.

Symtombild mellan episoder

Kartlägg symtom mellan typiska episoder. De akuta episoderna går vanligen över inom några månader men det är inte ovanligt med långdragna depressiva eller blandade episoder och nedsatt kognitiv funktion och funktionsförmåga. Psykosociala problem specifika för att ha en livslång, episodisk sjukdom kan även ha tillkommit. Det kan till exempel handla om hopplöshet inför att göra långsiktiga åtaganden, eftersom man inte vet när nästa episod kommer, eller avtal med en själv att begå självmord hellre än att genomgå ytterligare en depression.

Samlad bedömning

Gör en samlad bedömning och ett diagnostiskt ställningstagande med hänsyn tagen till den information som framkommit om patienten utifrån omdömesgill klinisk expertis och erfarenhet. Diagnos ställs av läkare och/eller psykolog. Specificera om patientens sjukdomsbild över tid bäst överensstämmer med bipolär typ 1 eller typ 2.

Informera alltid patienten om vilken diagnos som ställts och vad nästa steg är (se Behandling). Använd informationsmaterial som utgår från denna SVP eller lokal vårdprocess om sådan finns tillgängligt. Om bipolär sjukdom inte bedöms vara korrekt diagnos förklaras för patienten hur de problem som föranledde bedömningen i stället skulle kunna förstås.

Vårdnivåbedömning

Enligt aktuell (2022) handläggningsöverenskommelse psykiatri–primärvård behandlas nydiagnostiserade bipolära patienter inom specialistpsykiatrin. Stabila bipolära patienter kan

följas upp i primärvården förutsatt att snabb uppföljning i specialistpsykiatrin kan erbjudas vid återinsjuknande. Tillgång till samverkan/konsultation med specialistläkare i psykiatri ska då erbjudas vid behov, till exempel vid medicinjustering. Patienter med litiumbehandling bör alltid följas upp av specialistpsykiatrin.

NIVÅ 2

Vid diagnostisk osäkerhet behöver fördjupat ställningstagande göras avseende differentialdiagnostik, bland annat avseende personlighetssyndrom. Differentialdiagnostisk bedömning utförs i första hand av läkare och/eller psykolog.

Några hållpunkter för att skilja på om symtom beror på ADHD, bipolär sjukdom eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom återfinns bland annat i Adler (2014) och Wright et al. (2021).

Ibland kan det bli aktuellt med differentialdiagnostik mellan bipolär sjukdom typ 1 och schizoaffektivt syndrom. De två tillstånden är inte förenliga. Psykotiska symtom ska ha förelegat i minst två veckor under frånvaro av en svår förstämningsepisod vid schizoaffektivt syndrom, enligt DSM-5. En annan differentialdiagnos är cykloid psykos som kännetecknas av snabbt insjuknande och snabbt växlande förlopp med förvirring, stark ångest, växlande stämningsläge, vanföreställningar eller hallucinationer. Cykloid psykos brukar klassificeras som akut polymorf psykos enligt ICD-10 och kortvarig psykos enligt DSM-5 men kan även uppfattas som en manisk episod med psykotiska symtom vid bipolär typ 1. Kliniskt noteras stora likheter mellan cykloid psykos och postpartumpsykos.

Om bipolär sjukdom inte bedöms vara korrekt diagnos förklaras för patienten hur de problem som föranledde bedömningen i stället skulle kunna förstås.

Det finns även en hög grad av samsjuklighet vid bipolär sjukdom. Vanligast är substansrelaterade syndrom, ångestsyndrom, personlighetssyndrom, ADHD och tvångssyndrom. Vid misstanke om samsjuklighet bedöms detta enligt riktlinjer i respektive SVP. Förvissa dig om att samma exempel och livshändelser i anamnesen inte används för att bekräfta flera olika diagnoser, utifrån olika diagnostiska resonemang.

Om patienten förutom bipolär sjukdom även har psykiatrisk samsjuklighet, bedöm vad som utgör patientens största problem, vilken problematik som är mest funktionsnedsättande och därför bör prioriteras och behandlas först. I vissa fall kan behandling av två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt också vara motiverat.

NIVÅ 3

Vid kvarstående diagnostisk osäkerhet, rekommenderas att avvakta med diagnos och i stället observera patienten i cirka 6–12 månader vid planerade uppföljningstillfällen samt när patienten upplever symtom på hypomani eller mani. Låt patienten dagligen fylla i stämningsdagbok och seponera psykofarmaka när lämpligt.

Cirka 90–95 procent av äldre patienter har haft sin första episod före femtio års ålder. Sen debut är ofta relaterad till neurologisk eller annan somatisk samsjuklighet. CT/MR hjärna och ofta EEG bör då göras. Symtom på mani eller hypomani är som regel mindre uttalade medan depressiva och kognitiva symtom oftare ses. Psykiatrisk samsjuklighet är lägre hos äldre jämfört med yngre patienter. Ångest- och substansbruksyndrom är vanligt.

Diagnosspecifik patientinformation

Se bilaga 1.

Behandling

VÅRDPLAN

En vårdplan ska alltid upprättas och fortlöpande revideras. Vårdplanen görs i samråd med patienten men är också ett arbetsredskap och kommunikationsdokument för och mellan vårdpersonal. I vårdplanen ska anges vilka insatser som ska göras, av vem, hur lång tid insatsen planeras ta, samt när och hur den ska följas upp och utvärderas. Insatserna avgörs efter individuell bedömning med utgångspunkt i beslutade vårdprocesser och principen om stegvis vård (det vill säga insats på lägre nivå genomförs och utvärderas innan ställningstagande görs till insats på högre nivå) när relevant. I vissa fall bör behandling inledas med insatser på högre nivå. Patienten erhåller en utskrift av vårdplanen, alternativt tillgång via 1177.

Vanliga övergripande mål vid bipolär sjukdom är förbättrad kunskap om diagnosen, färdigheter i effektiva egenvårdsåtgärder, följsamhet till överenskommen medicinering, mindre frekventa och allvarliga stämningslägesförskjutningar och högre funktionsnivå till exempel vad gäller självständighet och sysselsättning. Vårdplanen ska även innehålla en krisplan (se nedan).

Förväntad tid för behandling av nydiagnostiserad patient med bipolär sjukdom utan samsjuklighet är 1–2 år på nivå 1 (episodförebyggande åtgärder samt behandling av eventuell aktuell episod). Efter denna period av aktiv behandling bör stabilisering, minskad risk för nya episoder, kortare episoder och ökad livskvalitet mellan episoder ha uppnåtts.

EPISODFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Episodförebyggande åtgärder blir oftast aktuella när patienten befinner sig i en mer eller mindre stabil fas. En bedömning har kunnat bekräfta diagnosen och patienten befinner sig inte i en akut, behandlingskrävande episod. Syftet är i första hand att minska frekvensen av, och reducera längden på, nya episoder. Därmed kan risken för suicid, för bestående funktionsförlust på sikt samt det lidande och den påverkan på livet som episoder för med sig minimeras. Syftet är även att höja funktionsförmågan och livskvaliteten mellan episoder.

Den teoretiska utgångspunkten för episodförebyggande åtgärder är den så kallade stress- och sårbarhetsmodellen: Psykosociala faktorer som stress, psykologisk sårbarhet, livsstilsfaktorer och socialt sammanhang samspelar med en stark medfödd komponent. Detta får till följd att utöver stämningsstabiliserande läkemedelsbehandling, i första hand litium, är även

beteendeförändringar och livsstilanpassningar nödvändiga för att minska risken för nya episoder. Hit hör en god kunskap om diagnosen, en hjälpsam inställning till sårbarhetens innebörd, effektiva egenvårdsåtgärder och aktiva beteendeförändringar.

Nivå 1

Medicinsk behandling

Mätvärden såsom längd, vikt, puls, blodtryck och EKG tas som utgångsvärden inför medicinsk behandling.

Litium är förstahandsval (”gold standard”) som långtidsprofylax vid bipolär sjukdom typ 1 (se bilaga 2). Det är effektivt i att förebygga mani och depression med starkare antimanisk förebyggande effekt samt antisuicidal effekt. Patienter som svarar bra på litium har ofta positiv ärftlighet på bipolär sjukdom, har släktingar som svarat bra på litium, lägre samsjuklighet, och mönstret ”MDI” (mani, depression och fria intervall/eutymi). Quetiapin är också ett evidensbaserat alternativ för monobehandling.

Det saknas i stort sett evidens för episodförebyggande medicinering vid bipolär sjukdom typ 2. Monoterapi med Lamotrigin, litium eller Quetiapin används på klinisk grund.

Generella principer vid episodförebyggande läkemedelsbehandling:

- Undersök tidigare behandlingsrespons/icke-respons under akuta faser, tolerans och biverkningar. Läkemedel som har varit effektivt i akuta faser bör användas som episodförebyggande med några undantag, exempelvis ska antidepressiv behandling helst inte användas som episodförebyggande utan kombination med stämningsstabiliserande läkemedel på grund av risk för switch samt instabilitet. Dosen kan minskas något under underhållsfasen.
- Bedöm och behandla samsjuklighet.
- Diskutera den förebyggande behandlingen med patienter och anhöriga. Patienten bör aktivt tillfrågas om biverkningar av läkemedelsbehandlingen. Patienten bör fortlöpande vara delaktig i vårdupplägget.
- Patienten bör ha behovsordination på sömnmedicin och/eller antimanisk medicin som Quetiapin eller Olanzapin.

Bipolär typ 1
Val av psykofarmaka

Nivå 1	Monoterapi: Litium eller Quetiapin
Nivå 2	Monoterapi: Valproat Kombinationsterapi: Tillägg av valproat, Quetiapin, Olanzapin, antidepressiva, Lamotrigin, Aripiprazol, Risperidon, Kariprazin eller Lurasidon
Nivå 3	Kombinationsterapi: Aripiprazol + Lamotrigin eller Olanzapin + Fluoxetin i kombination för patienter som svarat på denna behandling under akuta depressiva fasen. Klozapin som tillägg. Depotneuroleptika (Risperidon, Aripiprazol) kan vara ett alternativ för att förebygga mani när annan behandling inte går att genomföra

Bipolär typ 2 Val av psykofarmaka	
Nivå 1	Monoterapi med Lamotrigin, litium eller Quetiapin
Nivå 2	Tillägg av litium, Lamotrigin, Quetiapin eller SSRI
Nivå 3	Monoterapi, eller tillägg, med valproat

Psykoedukation

Patienter med bipolär sjukdom bör erbjudas psykoedukation i grupp som har ett interaktivt format och förmedlar kunskap om:

- Bipolär sjukdom och tidiga tecken (prodromer) på hypomani, mani, depression och blandad episod.
- Hur man kan övervaka (monitorera) och hantera stämningslägesförskjutningar, tidiga tecken och om vilka åtgärder som rekommenderas för att stävja begynnande episoder.
- Vikten av medicinering och livsstilsfaktorer såsom skiftesarbete.
- Generella och personliga sårbarhetsfaktorer såsom sömn, kost, motion, alkohol, droger och stress.

Målet med psykoedukation utöver förbättrade kunskaper och färdigheter är även att genom erfarenhetsutbyte med medpatienter och kursledare bättre förstå och acceptera sin sårbarhet, minska stigma och öka sitt eget ansvar för att minska risken för nya episoder genom gynnsamma livsstils- och beteendeförändringar.

Ett av de manualiserade, evidensbaserade psykoedukationsprogrammen Psychoeducation manual for bipolar disorder (Colom & Vieta, 2006) eller Life goals program (Bauer & MacBride, 2003) bör erbjudas för patienter i första hand. Omfattningen på dessa varierar från cirka fem månader, en gång per vecka, för Psychoeducation manual for bipolar disorder till cirka tio månader, en gång per vecka, för Life goals program.

Om implementering av evidensbaserat psykoedukationsprogram enligt ovan ej är möjligt kan i vissa fall anpassning behöva göras efter respektive verksamhetsområdes förutsättningar. Kunskapen som förmedlas bör dock vara densamma. Om gruppbehandling ej är möjligt att genomföra i verksamheten eller för enskild patient kan individuell psykoedukation på minst fem sessioner i undantagsfall erbjudas.

Även närstående bör erbjudas psykoedukation om bipolär sjukdom i någon form i syfte att minska närståendebörda (caregiver burden), öka förmågan att utgöra stöd för den som är patient samt minska risken för nya episoder till följd av konflikter och negativ kommunikation om bipolär sjukdom mellan patient och närstående.

Krisplan

En av de viktigaste icke-medicinska episodförebyggande åtgärderna är att tillsammans med patienten identifiera dennes mest typiska, individuella tidiga tecken (prodromer) på begynnande episoder samt föreslå effektiva strategier för att motverka eller begränsa utvecklingen till en episod. Målet är att tillsammans med patienten formulera en krisplan där tidiga tecken är tydligt operationaliserade och kopplade till konkreta strategier för att i tid hantera tecken på förhöjt eller sänkt stämningsläge. Närstående bör ges möjlighet att medverka om lämpligt och om patienten ger sitt medgivande.

Tidiga tecken ska helst vara med i alla episoder av samma typ och vara lätta för patienten att identifiera. De kan oftast kategoriseras utifrån:

- Symtomtecken (till exempel sänkt/ökad självkänsla eller förändring i sömnbehov).
- Perceptuella förändringar (till exempel upplever ljus och ljud som starkare).
- Beteendeförändringar (som inte tydligt är kopplade till symtom till exempel börja röka, ha andra kläder på sig eller lyssna på annan musik än vanligt).
- Kvantitativa förändringar (för en själv normala saker men mer och intensivare som att prata fortare, känna sig gladare, tänka snabbare, röra sig snabbare och vara vaken mer).
- Kvalitativa förändringar (för en själv onormala saker till exempel om normalt mild och lugn i humöret blir irriterad och högljudd).

Var dock aktsam på den potentiellt iatrogena effekten av överdriven patologisering av normala fluktuationer i stämningsläge!

Effektiva åtgärder att genomföra när tidiga tecken identifierats behöver alltid individualiseras men handlar ofta om att:

- Öka eller minska sömn, stimulans och aktivitet.

- Vara noga med regelbundna vanor.
- Medicinjustering eller vid behovs-medicinering enligt ovan.
- Undvika alkohol och droger.
- Akuta tider för samtal eller rådgivning.

Tydliga instruktioner för hur man arbetar med tidiga tecken återfinns bland annat i Lam, Jones & Hayward (2010, s. 213 ff.) och Basco & Rush (2007, s. 118ff).

En beskrivning av patientens individuella tidiga tecken och vilka åtgärder som behöver vidtas när dessas identifieras sammanfattas i ett dokument (krisplan) som patienten (och närstående) tar hem. En kopia skannas in i patientens journal med tydlig hänvisning i patientens vårdplan. Detta dokument kan sedan behöva revideras efter ytterligare episoder. Tidsomfattningen av att upprätta en krisplan uppgår vanligtvis till mellan 3–5 individuella samtal.

Att över tid dagligen använda sig av stämningsdagbok i pappersform eller mobilapplikation kan för en del patienter vara till stor hjälp för att tidigt uppmärksamma sig själv på tidiga tecken och då aktivera sin krisplan.

Nivå 2

Medicinsk behandling

För bipolär typ 1 är valproat ett alternativ som maniprofylax när litium inte fungerar (dock ej för kvinnor i fertil ålder). Valproat och litium kan även användas i kombination i vissa fall för att förstärka den antimaniska effekten.

Tillägg av Quetiapin, Olanzapin, antidepressiva, Lamotrigin, Aripiprazol, Risperidon, Kariprazin eller Lurasidon (enligt internationella riktlinjer, se till exempel Yatham et al, 2018, Kariprazin och Lurasidon på väg att godkännas i Europa på indikation bipolär sjukdom) är evidensbaserade alternativ om monobehandling med litium inte ger stabilisering. Valet beror på biverkningsprofil och vilken episod som måste förebyggas mest kraftfullt.

För bipolär typ 2 tillägg av litium, Lamotrigin, Quetiapin eller SSRI med hänsyn tagen till symtom, förlopp och biverkningar.

Krisplan

Suicidrisken är särskilt hög för patienter med bipolär sjukdom och när relevant behöver en krisplan specifikt för suicidrisk upprättas för att förebygga och hantera framtida situationer med förhöjd suicidrisk. En sådan krisplan behöver identifiera risksituationer och varningstecken på begynnande allvarlig suicidalitet och åtgärder för att reducera risk. Hit hör att minska tillgången till medel både förebyggande som att till exempel lämna in överblivna mediciner men också mer akut som att lämna ifrån sig bilnycklar och uppsöka vården (psykakut).

SPI (Safety Planning Intervention) är en strukturerad metod för krisplan som i första hand bör användas vid återkommande suicidala kriser.

Psykiatrisk omvårdnad och kurativa insatser

För patienter med brister i allmän daglig livsföring behöver insatser genomföras för att höja patientens generella funktionsnivå till exempel vad gäller kost, sömn, hygien med mera. Övriga områden inom vilka patienten kan uppvisa låg funktionsnivå är hemliv, arbete, studier och fritidsaktiviteter. Insatser i form av färdighetsträning, samtal kring aktivitetsbalans, anpassningar i miljö och inventering av hjälpmedelsbehov kan här bli aktuella. Hembesök, liksom även besök på patientens arbets- och studieplats, kan initieras vid behov. Samarbete med aktörer som kommun, skola och arbetsgivare eller arbetsförmedling är viktigt för att patienten ska få rätt stöd i vardagen och öka sin delaktighet i samhället vilket i sin tur kan bidra till prevention av bipolära episoder.

Psykoterapi

Psykoterapi särskilt avsedd för bipolär sjukdom enligt någon av nedanstående metoder bör erbjudas som komplement till psykoedukation i grupp (se ovan) när patienten uppvisar fortsatt stora problem med stämningslägesförskjutningar och samtidigt bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig en psykoterapi:

- Kognitiv beteendeterapi för bipolär sjukdom (Lam et al., 2010; Basco & Rush, 2007)
- Familjefokuserad terapi för bipolär sjukdom (Miklowitz et al., 2008)
- Interpersonell och social rytmterapi för bipolär sjukdom (Frank, 2007)

Omfattningen på dessa behandlingar är vanligtvis 20–25 sessioner en gång per vecka, det vill säga 5 – 6 månader. Behandlaren bör ha erfarenhet av att arbeta med patienter som har bipolär sjukdom. Konceptualiseringen av patientens svårigheter och behandlarens kompetens bör styra val av intervention då metoderna har likvärdig evidens och prioriteringsgrad (se bland annat Yatham, 2018 samt NICE, 2022).

Nivå 3

Medicinsk behandling

Vid bipolär typ 1 rekommenderas på nivå 3 Aripiprazol + Lamotrigin eller Olanzapin + Fluoxetin i kombination för patienter som tidigare svarat på denna behandling under akut depressiv fas. Klozapin kan övervägas som tillägg.

Depotneuroleptika (Risperidon, Aripiprazol) kan vara ett alternativ för att förebygga mani när annan behandling inte går att genomföra. Evidens finns för att antipsykotika i kombination med litium eller valproat reducerar risken för återinsjuknandet i mani under de första sex månaderna, dock är nyttan med användning av atypiska neuroleptika efter denna period oklar varför det rekommenderas att fortsatt behov av behandling med atypiska neuroleptika alltid utvärderas.

Vid bipolär typ 2 kan monoterapi eller tillägg med valproat övervägas.

Behandling av samsjuklighet

Det är vanligt med psykiatrisk samsjuklighet vid bipolär sjukdom. I dessa fall rekommenderas i första hand behandling enligt respektive standardiserade vårdprocess. Vid prioritering behöver hänsyn tas till vilket tillstånd som resulterar i allvarligast risk, svårast funktionsnedsättning eller vilket tillstånd som framför allt begränsar möjligheten att tillgodogöra sig vård. Som regel bör man börja med stämningsstabiliserande läkemedel före behandling av samsjuklighet. Till exempel bör stämningsstabilisering föregå behandling mot ADHD eftersom centralstimulantia kan trigga mani (Yatham et al., 2018).

Samsjuklighet med bipolär sjukdom och annan psykopatologi påverkar i undantagsfall varandra på ett så komplext sätt att förväntad behandlingseffekt av standardiserad behandling uteblir. Exempel på detta kan vara när en separation utlöser blandad episod vid samtidig bipolär sjukdom och emotionellt instabilt personlighetssyndrom eller när hypomani utlöser

återfall i missbruk vid samtidig beroendesjukdom. I sådana fall behöver behandlingen ta hänsyn till de olika tillstånden samtidigt och medicinsk och psykologisk behandling individualiseras utifrån en samlad bedömning. Exempel på detta kan vara generalistisk behandling för personlighetssyndrom (till exempel GPM, se SVP Personlighetssyndrom) parallellt med förebyggande medicinsk behandling för bipolär sjukdom och samtidigt deltagande i psykoedukationsprogram. Vid dubbeldiagnos erbjud alltid kontakt med beroendevård och inled ett samarbete som gör det möjligt att behandla missbruk och bipolär sjukdom samtidigt enligt gällande riktlinjer.

Planering av graviditet

Att bli förälder kan innebära stora konsekvenser vid bipolär sjukdom ur farmakologisk synvinkel, risk för försämring och risk för påverkan på fostret och barnet. Det finns risk för nya sjukdomsepisoder, särskilt för modern i samband med postpartumperioden. Fosterutvecklingen, med till exempel risk för låg födelsevikt, kan påverkas om modern är deprimerad. Anknytningsprocessen mellan förälder och barn kan försvåras och barnets utveckling påverkas vid nya sjukdomsepisoder. Den farmakologiska behandlingen kan innebära risker för fostret och det ammade barnet.

Planera därför behandling och uppföljning minst tre månader före planerad graviditet eller omedelbart vid redan konstaterad graviditet. Gå igenom medicinlista, sätt ut olämplig medicinering (observera att valproat inte ska ges till fertila eller gravida kvinnor) samt anpassa farmakadoser utifrån planerad graviditet.

- Lågriskpatient: Om patienten varit stabil under lång tid och inte tidigare fått snabba och allvarliga insjuknanden vid utsättning av farmaka föreslås att litium eller andra psykofarmaka sätts ut före planerad graviditet. Utsättningen bör ske långsamt, litium under cirka tre månader för att minska risken för recidiv.
- Mellanriskpatient: Utsättning av farmaka före graviditeten kan övervägas och återinsättande ske efter första trimestern.
- Högriskpatient: Om patienten är instabil, har tidigare svåra sjukdomsepisoder eller tidigare postpartumepisoder rekommenderas som regel att fortsätta med litium eller andra farmaka.

Vid redan konstaterad graviditet, utan att föregående planering kunnat göras, bör principerna ovan följas men eventuell utsättningstid av farmaka blir då kortare.

Upprätta vårdplan för omhändertagande inför/under graviditet och postpartumperiod. En tät uppföljning av det psykiatriska tillståndet före och efter förlossningen är viktigt.

Kontakt med specialistmödravården bör etableras. Planera för förlossningen, patienten kan behöva förlängd vårdtid på BB.

Kontakt med socialtjänst och orosanmälan ska alltid övervägas. Remiss till särskild spädbarnsmottagning med fokus på anknytning kan bli aktuell.

Äldre patienter med bipolär sjukdom

Den medicinska behandlingen skiljer sig inte åt jämfört med sådan som ges till yngre patienter. Hänsyn måste dock tas till förändringar i farmakokinetik och farmakodynamik relaterat till åldern liksom till eventuella interaktioner med annan behandling för somatisk sjukdom. Som regel behövs lägre doser. Vid behandling med litium bör koncentrationen ligga i nedre delen av det terapeutiska intervallet. Patienter kan i vissa fall komma upp till terapeutisk koncentration enbart med en litiumtablett varför extra försiktighet bör iakttas. Preparat med hög antikolinerg effekt kan ge försämrad kognition.

BEHANDLING VID PÅGÅENDE MANISK ELLER HYPOMANISK EPISOD

Nivå 1

Medicinsk behandling

Vid tidiga tecken eller symtom på hypomani, behandla sömnstörningen och optimera den övriga stämningsstabiliserande behandlingen. Detta kan göras i öppenvård. Snabba insatser (inom en eller några dagar) är ofta avgörande för att en episod ska kunna avvärjas. Patienten bör sedan tidigare ha behovsordination på sömnmedicin och/eller antimanisk medicin som Quetiapin eller Olanzapin. Kortare sjukskrivning kan bli aktuellt.

Psykiatrisk omvårdnad och kurativa insatser

Samtal med behandlare bör erbjudas inom ett fåtal arbetsdagar vid tidiga tecken eller symtom på hypomani. Informera patient och närstående om vikten av att begränsa stimuli till exempel genom att avboka möten, nöjen och resor; lämna ifrån sig betalkort och avstå från sociala medier. Patienten behöver framför allt få accept i att dra sig undan och vila/sova i en stimulifattig miljö under kortare period. Ge råd om sömnreglering. Intensiv fysisk träning bör pausas. Om patient har behovsmedicin, rekommendera ordinerad kur. Följ upp efter några dagar så att det fungerar. Bevaka läkare. Om mer allvarlig uppvarvning samma råd, men kontakta läkare som följer upp.

Nivå 2

Medicinsk behandling

Vid manisk episod, ta ställning till behov av inläggning och vård enligt LPT. Maniska patienter behöver oftast heldygnsvård. Även vid en mani kan det finnas suicidrisk, särskilt vid inslag av dysfori och blandade symtom. Kontinuerlig tillsyn kan ibland behövas. Av fullbordade suicid inträffar 14 procent under slutenvård och 26 procent inom sex veckor efter utskrivning. Det är därför viktigt att följa upp och observera suicidrisk.

Avsluta behandling med antidepressiva och centralstimulantia. Sätt ut/minska eventuell kortisonbehandling. Om litiumbehandling pågår, kontrollera koncentrationen och ta ställning till doshöjning samt tillägg av antipsykotiskt preparat.

Monoterapi med Olanzapin, Quetiapin, Risperidon har god evidens. Olanzapin är dock andrahandsalternativ vid längre tids behandling på grund av biverkningar. Även Aripiprazol,

litium, valproat, Haloperidol, Ziprazidon och Paliperidon har god evidens. Effekt- och biverkningsprofil för den enskilde patienten blir ofta avgörande för val av preparat.

Preparat med god evidens för akutbehandling av mani/hypomani

Preparat	Dos/s-konc:	Kommentar:
Litium	0,8–1,2 mmol/l	Toxicitetsrisk
Olanzapin	5–30 mg/dygn	Sedation, metabola symtom
Aripiprazol	15–30 mg/dygn	Akatisi, illamående
Risperidon	2–6 mg/dygn	EPS*, prolaktinemi
Paliperidon	3-6 mg/dygn	EPS*, prolaktinemi
Haloperidol	2–10 mg/dygn	EPS*, prolaktinemi
Valproat	1200–2000 mg/dygn, 350–700 µmol/l	Sedation och viktuppgång, ej till fertila kvinnor pga. teratogenicitet
Quetiapin	600–800 mg/dygn	Sedation, yrsel
Ziprazidon	80–160 mg/dygn	QT förlängning
Injektionsbehandling:		
Haloperidol	5–10 mg	
Zuklopentixolacetat	50–100 mg	
Aripiprazol	7,5–15 mg	
Lorazepam	2–4 mg	
Prometazin	25–100 mg	
Biperiden	2,5–5 mg	Mot akut dystoni

*EPS=Extrapyramidala symtom

Efter episod ska ställningstagande till eller optimering av underhållsbehandling och behovsmedicinering göras, se Episodförebyggande åtgärder.

Psykiatrisk omvårdnad och kurativa insatser

Vid inläggning bör omvårdnaden innefatta begränsning av aktiviteter och undvikande av konfrontation samt ett respektfullt bemötande. Vikt tas vid inskrivning, nutrition och elimination kontrolleras.

Efter hypoman eller manisk episod bör samtal med behandlare erbjudas där utlösande faktorer kartläggs och utifrån dessa upprättas eller revideras krisplan avseende tidiga tecken på

återinsjuknande och åtgärder, se Episodförebyggande åtgärder. I dessa samtal bör även stöd erbjudas i att hantera konsekvenser av hypomani/mani (till exempel ekonomiska, relationella eller sysselsättningsrelaterade) för att minska sårbarheten för ny episod.

Vid behov ska patienten erbjudas hjälp med att komma i kontakt med budget- och skuldrådgivning i kommunal regi.

Om episoden har resulterat i vidlyftiga inköp bör möjligheten att häva dessa enligt Lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning undersökas.

Nivå 3

Medicinsk behandling

Sätt in kombinationsbehandling med litium eller valproat och Olanzapin, Quetiapin, Aripiprazol eller Risperidon vid terapisvikt på monoterapi eller vid allvarlig mani. Patienten bör aktivt tillfrågas om biverkningar av läkemedelsbehandling.

Behandla agitation och sömnstörning. Lorazepam har ofta god effekt vid agitation se även aktuellt PM för akut sedation. Injektionsbehandling kan bli nödvändig. Ge Nitrazepam 5–10 mg till natten alternativt Zopiklon 7,5–15 mg. Vid sedation kontrollera andning, puls och blodtryck.

Vid deliriös mani, suicidtankar, postpartumpsykos, cykloid psykos och somatiskt sjuka patienter där snabb respons är angelägen, överväg alltid ECT.

Under och efter graviditet samt postpartumpsykos

Risken att utveckla hypomani, mani och psykos efter förlossning är störst de första två veckorna men risken kvarstår det första halvåret. Kvinnor med tidigare postpartumpsykos har en ökad risk och får återfall i upp till 60 procent vid en ny förlossning. En postpartumpsykos är ofta av cykloid typ, det vill säga en psykos med snabbt insjuknande och snabbt växlande förlopp med förvirring, stark ångest, växlande stämningsläge och olika vanföreställningar. Suicidrisken är stor. Det finns även risk för infanticid. Tillståndet kräver snabb handläggning och slutenvård, ofta enligt LPT. Om patienten befinner sig på BB ska kontinuerlig tillsyn sättas in och akut psykiaterkonsultation göras. Som regel bör patienten överföras till psykiatrisk vårdavdelning.

Vid mani är principerna desamma som vid behandling av mani i övrigt med hänsyn taget till enskilda läkemedels påverkan vid graviditet och amning. Se läkemedel under graviditet och postpartumperiod. Vid postpartumpsykos och deliriös mani är ECT ofta förstahandsbehandling.

Nära kontakt med mödravård och barnavård rekommenderas. Kontakt med socialtjänst ska alltid övervägas och orosanmälan bör göras. Remiss till särskild spädbarnsmottagning med fokus på anknytning bör erbjudas patienten.

BEHANDLING VID PÅGÅENDE DEPRESSIV EPISOD

Nivå 1

Medicinsk behandling

Vid tidiga tecken på depression, optimera den stämningsstabiliserande behandlingen och eventuell sömnmedicinering. Tillägg med ett antidepressivt läkemedel till pågående välinställd stämningsstabiliserande behandling kan övervägas, till exempel SSRI eller Bupropion. Tricykliska antidepressiva och Venlafaxin ökar risken för switch till mani/hypomani mer än andra antidepressiva. Monoterapi med antidepressiva läkemedel rekommenderas inte. Dessa åtgärder kan göras i öppenvård. Sjukskrivning kan bli aktuellt.

Psykiatrisk omvårdnad

Samtal med behandlare bör erbjudas vid tidiga tecken eller symtom på depression. Informera patient och närstående om vikten av att öka stimuli till exempel genom att boka in sociala och på annat sätt stimulerande händelser, bryta tendenser till undvikanden och passivitet, öka mängden fysisk träning (överväg FAR) och vårda sina nära relationer. Ge råd om sömnhygien. Se även Uppföljning och utvärdering.

Nivå 2

Medicinsk behandling

Quetiapin har bäst evidens för monoterapi vid bipolär typ 1- och 2-depression. Vid bipolär typ 1 har även Olanzapin i kombination med Fluoxetin god evidens men rekommenderas inte i första hand på grund av biverkningsprofilen.

Om patienten står på litium som underhållsbehandling kontrollera koncentrationen och öka dosen om möjligt till en koncentration på 0,8–1,0 mmol/l. Litium i monoterapi har svagare evidens men anses ändå vara ett förstahandsalternativ vid bipolär typ 1-depression i CANMAT:s och ISBD:s riktlinjer (Yatham et al., 2018). Koncentrationen bör dock vara 0,8–1,2 mmol/l i monoterapi.

Aripiprazol i låg dos kan ha snabb men ofta övergående effekt (Yatham, 2011).

Lurasidon (enligt internationella riktlinjer, se till exempel Yatham et al., 2018, på väg att godkännas i Europa för bipolär sjukdom) i kombination med litium eller valproat har god evidens vid bipolär typ 1-depression.

Lamotrigin i monoterapi kan ges framför allt vid bipolär typ 2-depression men bör kombineras med stämningsstabiliserare med antimaniskt skydd vid bipolär typ 1. Användningen begränsas dock av den nödvändiga långsamma upptrappningen av dos. Lamotrigindosen i monoterapi bör vara högre än 200 mg men högst 400 mg. Om patienten redan står på Lamotrigin bör koncentrationen kontrolleras. Observera att Lamotrigin interagerar med valproat som minskar metabolismen av Lamotrigin varför lägre, halverad dos behövs. P-piller ökar däremot metabolismen och högre dos Lamotrigin krävs. Tänk på att

koncentrationen av Lamotrigin ändras när valproat eller p-piller sätts ut eller patienten blir gravid.

Tillägg med ett antidepressivt läkemedel till pågående välinställd stämningsstabiliserande behandling kan övervägas, till exempel SSRI eller Bupropion. Tricykliska antidepressiva och Venlafaxin ökar risken för switch till mani/hypomani mer än andra antidepressiva. Monoterapi med antidepressiva är omdiskuterat men kan användas i enstaka fall vid bipolär sjukdom typ 2 hos patienter med ren depression utan blandade symtom.

Initialt tät kontakt med patienten som sedan kan glesas ut efterhand. Först när patienten varit stabil en längre tid kan den farmakologiska behandlingen minskas.

Vid svår depression ta ställning till inläggning. Allvarliga suicidtankar och/eller depressiva vanföreställningar är en absolut indikation för inläggning. Vid melankoliska symtom och stark ångest bör också inläggning övervägas. Tillsynsgrad ska alltid bedömas. Av fullbordade suicid inträffar 14 procent under slutenvård och 26 procent inom sex veckor efter utskrivning. Det är därför viktigt att följa upp och observera suicidrisk!

Preparat för behandling av bipolär depression

Preparat	Dos/s-konc	Kommentar
Quetiapin	Upptrappning mot 300 mg	Sedation, metabol risk
Litium	0,7–1,0 mmol/l	Tremor, diarré, hypotyreos
Aripiprazol	2,5–5 mg	Ej indikation i FASS
Olanzapin + SSRI	2,5–10 mg	Evidens finns för Fluoxetin tillsammans med Olanzapin
Lurasidon	18–37 mg	Ej indikation i FASS
SSRI		Ej evidens, endast i kombination med stämningsstabiliserare
Bupropion	150–300 mg	som ovan
Kariprazin	1,5–4,5 mg	Ej indikation FASS.
Lamotrigin	Öka underhållsdos	Förhållandevis lång tid till effekt

Psykiatrisk omvårdnad och kurativa insatser

Vid inläggning bör omvårdnaden innefatta ökning av aktiviteter, sociala stimuli och fysisk aktivitet, och undvikande av konfrontation samt ett respektfullt bemötande. Vikt tas vid inskrivning, nutrition och elimination följs upp.

Efter depressiv episod bör samtal erbjudas där utlösande faktorer kartläggas och utifrån dessa krisplan upprättas eller revideras avseende tidiga tecken på återinsjuknande och åtgärder, se Episodförebyggande åtgärder. Faktorer som innebär ökad sårbarhet för ny episod såsom

missbruk, livsstil, relationsmönster, brist på sysselsättning och ensamhetsproblematik bör kartläggas och insatser för att påverka dessa bör erbjudas.

Nivå 3

Medicinsk behandling

Överväg ECT vid svår depression särskilt vid suicidtankar, psykotiska symtom och katatona symtom. rTMS (repetitiv transkraniell magnetstimulering) kan vara ett alternativ för medelsvår och svår depression utan psykotiska symtom. Behandlingen är dock inte lika väl studerad som ECT. Stämningsstabiliserande behandling måste ges samtidigt med rTMS men antiepileptika minskar troligen behandlingseffekten.

MAO-hämmare kan övervägas vid atypiska och långdragna symtom men denna behandling kräver dietrestriktioner. Stämningsstabiliserande behandling måste ges samtidigt med MAO-hämmare.

Psykoterapi

Vid lindrig till måttlig bipolär depression rekommenderas psykoterapi enligt någon av nedanstående metoder i de fall där patienten bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig en sådan. Val av metod avgörs av konceptualisering av patientens problematik och behandlarens kompetens då metoderna har likvärdig evidens och prioriteringsgrad (se bland annat Yatham, 2018 samt NICE, 2022).

- Kognitiv beteendeterapi (KBT) för depression
- Interpersonell terapi (IPT) för depression
- Kognitiv beteendeterapi för bipolär sjukdom
- Familjefokuserad terapi för bipolär sjukdom
- Interpersonell och social rytmterapi för bipolär sjukdom

Omfattningen på dessa behandlingar är vanligtvis 12–25 sessioner 1 gång per vecka, det vill säga 3–6 månader. Behandlaren bör ha erfarenhet av att arbeta med patienter som har bipolär sjukdom.

Under graviditet och postpartumperioden

Vid svår depression kan vård enligt LPT behövas. Det kan finnas risk för infanticid. Suicidrisken ska alltid värderas.

Principerna för behandling är desamma som vid bipolär depression i övrigt men med hänsyn taget till den risk som finns för respektive läkemedel vid graviditet och amning. Se medicinsk behandling under graviditet och postpartumperiod nedan.

Risken för missbildningar är högst under första trimestern. Om patienten behöver läkemedel bör monoterapi eftersträvas och lägsta möjliga dos användas.

Medicinsk behandling under graviditet och postpartumperiod

Preparat	Kommentar
Litium	Litiumbehandling under första trimestern ökar risken något för hjärtmissbildning. Står patienten på litium bör ett extra ultraljud utföras i vecka 16–18.
	Koncentrationen bör mätas en gång/månad men sista månaden före partus bör mätning göras en gång/vecka. Följ även TSH.
	Litiumkoncentrationen kan sjunka i slutet av graviditeten och dosökning kan behövas. Dosen bör dock sänkas 1–2 dagar före förlossning för att undvika litiumförgiftning och neonatala komplikationer. Efter förlossning måste ny koncentration tas omgående. Amning avråds då litium går över i bröstmjölk i hög grad.
Antipsykotika	Quetiapin, Olanzapin och Risperidon under graviditet ger ingen ökad risk för missbildningar i de få studier som publicerats men risk kan inte uteslutas (riskgrupp C enligt FDA). Dessa läkemedel anses innebära låg risk vid amning (L2 enligt FDA) men ställningstagande till att avstå/avbryta amning bör göras.
Lamotrigin	Koncentrationsbestämning bör göras under graviditet, anses ha låg risk för missbildningar vid en dos under 200 mg. Amning bör undvikas, går över i bröstmjölk med upp till 25 procent av mammans koncentration.
SSRI	Sertralin, citalopram och fluoxetin bedöms inte ge ökad missbildningsfrekvens. Exposition under sista trimestern kan dock öka risken för neonatala komplikationer som hypotoni, uppfödningssvårigheter och kramper. Mängden av SSRI som går över i bröstmjölk är liten och anses förenlig med amning.
Bupropion	Motsägelsefulla resultat avseende användning under graviditet. Amning avrådes.
Bensodiazepiner och hypnotika	Bör endast användas tillfälligt och kortverkande preparat väljas, till exempel Oxazepam eller vid sömnstörning Zolpidem. Prometazin under graviditet anses innebära låg risk.
ECT	Är indicerad vid mycket svår depression med hög suicidrisk eller katatoni. ECT under graviditet har tidigare ansetts vara förenat med relativt låg risk men nyare undersökningar har visat högre risk. Behandlingen måste ske i nära samverkan med anestesi, obstetrik och pediatrik.

Nära kontakt med mödravård och barnavård rekommenderas. Tät uppföljning med sjuksköterska. Kontakt med socialtjänst och orosanmälan ska alltid övervägas. Remiss till särskild spädbarnsmottagning med fokus på anknytning kan bli aktuell.

BEHANDLING VID PÅGÅENDE BLANDAD EPISOD

Nivå 1

Medicinsk behandling

Vid tidiga tecken eller symtom på blandad episod, behandla sömnstörningen och optimera den övriga stämningsstabiliserande behandlingen. Detta kan göras i öppenvård. Snabba insatser (inom en eller några dagar) är ofta avgörande för att en episod ska kunna avvärjas. Patienten bör sedan tidigare ha behovsordination på sömnmedicin och/eller antimanisk medicin som Quetiapin eller Olanzapin. Sjukskrivning kan bli aktuellt. Blandad episod är den högsta riskfaktorn för suicid vid bipolär sjukdom och är associerad med en ökning av risken för suicidförsök med 6500 procent (Holma, 2014, citerad i Yatham, 2021). Bedöm därför alltid suicidrisken kontinuerligt vid blandad episod.

Psykiatrisk omvårdnad

Samtal med behandlare bör erbjudas inom ett fåtal arbetsdagar vid tidiga tecken eller symtom på blandad episod. Gör alltid suicidriskbedömning enligt gällande rutin. Informera patient och närstående om vikten av att begränsa stimuli till exempel genom att avboka möten, nöjen och resor. Patienten bör lämna ifrån sig betalkort och avstå från sociala medier. Patienten behöver framför allt få accept i att dra sig undan och vila/sova i en stimulifattig miljö under kortare period. Ge råd om sömnreglering. Intensiv fysisk träning bör pausas. Se även Uppföljning och utvärdering.

Om patient har behovsmedicin, rekommendera ordinerad kur. Följ upp efter några dagar så att det fungerar. Bevaka läkare. Om mer allvarlig uppvarvning samma råd, men kontakta läkare som följer upp.

Nivå 2

Medicinsk behandling

Initialt tät kontakt med patienten som sedan kan glesas ut efterhand. Först när de akuta symtomen på blandad episod är hävda kan den farmakologiska behandlingen minskas.

Inläggning blir ofta aktuellt. Kontinuerlig tillsyn kan då vara nödvändig utifrån den mycket höga suicidrisken vid blandad episod. Vid svår blandad episod kan ECT vara aktuell. Ta ställning till behov av inläggning och vård enligt LPT.

Kombinationsbehandling krävs oftast enligt riktlinjer för behandling mot mani. Atypiska antipsykotika och valproat fungerar möjligen bättre än litium i kombination.

Antidepressiva eller centralstimulantia ska inte användas.

Patienten bör aktivt tillfrågas om biverkningar av läkemedelsbehandling.

Efter episod ska ställningstagande till eller optimering av underhållsbehandling och behovsmedicinering göras, se ”Episodförebyggande åtgärder”.

Preparat för behandling av blandad episod

Preparat	Dos/s-konc	Kommentar
Olanzapin	2,5–20 mg	Metabol risk, sedation
Aripiprazol	10-20 mg	Akatisi
Valproat	600–1200 mg 350–700 µmol/l	Leverpåverkan, GI-biverkan, och viktuppgång. Ej till fertila kvinnor på grund av teratogenicitet.
Quetiapin	upptrappning mot 600 mg	Sedation, metabol risk
Cariprazine	1,5–4,5 mg	Ej indikation FASS.

Psykiatrisk omvårdnad, psykologiska och kurativa insatser

Omvårdnaden bör vid förhöjd risk omfatta återkommande suicidriskbedömningar (vid inläggning även observation av suicidrisk), begränsning av aktiviteter, undvikande av konfrontation samt ett respektfullt bemötande. Vikt tas vid inskrivning, nutrition och elimination kontrolleras.

Upprätta en krisplan specifikt för suicidrisk när sådan föreligger till exempel utifrån SPI (Safety Planning Intervention). Krisplanen behöver identifiera risksituationer, varningstecken och åtgärder för att reducera risk som att lämna in överblivna mediciner, lämna ifrån sig bilnycklar och uppsöka vården för akut psykiatrisk bedömning.

Efter blandad episod bör samtal med behandlare erbjudas där utlösande faktorer kartläggs och utifrån dessa upprättas eller revideras krisplan avseende tidiga tecken på återinsjuknande och åtgärder, se Episodförebyggande åtgärder. I dessa samtal bör även stöd erbjudas i att hantera konsekvenser av blandad episod (till exempel ekonomiska, relationella eller sysselsättningsrelaterade) för att minska sårbarheten för ny episod.

Vid behov ska patienten erbjudas hjälp med att komma i kontakt med budget- och skuldrådgivning i kommunal regi. Om episoden har resulterat i vidlyftiga inköp bör möjligheten att häva dessa enligt Lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning undersökas.

Rehabilitering/återhämtning/samverkan

Att diagnostiseras med en allvarlig och många gånger livslång psykiatrisk sjukdom påverkar patienter olika. Sättet man integrerar detta i sin självbild påverkar i vilken utsträckning man är mottaglig för och följsam till behandling, egenvårdsåtgärder och nödvändiga livsstilsförändringar. Hög grad av acceptans, god förmåga att skilja mellan person och diagnos och stort eget ansvar för att så långt det är möjligt hantera sin sårbarhet är prognostiskt gynnsamt.

Ur ett patientperspektiv kan ”återhämtning” handla om att leva ett så bra, eller meningsfullt, liv som möjligt trots eventuella begränsningar som den psykiska sjukdomen innebär för förmåga, ambitioner, drömmar med mera. Känsla av sammanhang (KASAM), upplevelse av tillhörighet, hopp, självbild, meningsfullhet och egenmakt bidrar alla till den egna återhämtningen.

Återhämtning är både en individuell och en social process. Individuell i meningen att det endast är patienten i fråga som vet vilka faktorer som gör livet meningsfullt för just en själv (det vill säga vad som motiverar till återhämtning) och vad som konkret utgör framsteg i den egna återhämtningsprocessen. Social i betydelsen att patienten behöver stöd av vården, närstående och andra aktörer för att göra sina sjukdomserfarenheter begripliga, få teoretisk kunskap om och praktiska strategier för att hantera sin sjukdom, samt få möjlighet att samtala med andra som har samma eller liknande erfarenheter av psykisk sjukdom.

NIVÅ 1

Återhämtningsguiden rekommenderas för alla patienter med bipolär sjukdom. Detta är material (digitalt och skriftligt) som tagits fram av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa i samarbete med närstående, kliniker och forskare som stöd för den som mår psykiskt dåligt och dennes närstående. Materialet kan användas tillsammans med behandlare, av patient och närstående själva eller i grupp tillsammans med andra.

NIVÅ 2

Kontakt med peer support individuellt, i grupp eller genom patientförening rekommenderas för vissa patienter i syfte att öka acceptans och minska självstigma när detta utgör ett hinder för annan behandling, stabilitet och förbättrad funktion. NECT (Narrative Enhancement Cognitive Therapy) kan erbjudas när tillgång till peer support eller motsvarande insats riktad mot återhämtning och självstigma saknas.

Under vårdprocessen bör patientens vård vid behov kompletteras med sociala/kurativa och rehabiliterande insatser som är riktade mot ökad funktion och färdigheter vad gäller sysselsättning, arbete, studier och boende. Insatserna kan handla om information och rådgivning till patient och anhöriga avseende samhälleliga funktioner, tandvårdsbidrag, samverkan med kommun samt familj- och nätverksarbete samt koordinering av insatser mellan olika huvudmän som till exempel kommun, försäkringskassa arbetsgivare/arbetsförmedling, övrig sjukvård och habilitering. Vid behov kan vissa patienter även behöva kartläggning och bedömning av psykosocial situation samt förstärkt stöd i kontakten med myndigheter till exempel Försäkringskassan, arbetsförmedling och socialtjänst.

För patienter som lever tillsammans med familj och barn kan särskilda insatser bli aktuella då diagnosen bipolär sjukdom kan innebära stor påverkan på övriga familjemedlemmar. Redan i samband med att patienter med bipolär sjukdom väntar barn behöver insatser från specialistmödravård och kontakt med socialtjänst övervägas för att erbjuda anpassat stöd för familjemedlemmarna.

Patienter med barn under 18 år bör aktualiseras för särskild psykosocial insats med fokus på barnperspektiv enligt 5 kap, 7§ HSL. Detta ska göras även om det inte finns misstanke om barn som far illa. Skulle sådan misstanke finnas är den vårdpersonal som fattar sådan misstanke skyldig att göra anmälan till Socialtjänsten enligt 14 kap § 1 SoL. Det är dock viktigt att poängtera att även barn som inte misstänks fara illa i sin hemmiljö ofta har behov av insatser som hjälper familjen att hantera de påfrestningar som psykisk sjukdom innebär. Sådan psykosocial intervention bör ges av personal som har särskild träning och utbildning inom detta område. Se även Handlingsprogram barn som anhöriga och Handlingsprogram för barn som far illa eller riskerar att fara illa.

NIVÅ 3

Ett fåtal patienter har på grund av kronisk instabilitet, frekventa inläggningar, hög risk och dåligt behandlingssvar och/eller följsamhet behov av mer omfattande och aktiva insatser från

både specialistpsykiatri och kommun. I första hand rekommenderas då Assertive Community Treatment (ACT) eller Flexible Assertive Community Treatment (FACT), i andra hand vård i ett multiprofessionellt team med case management som på motsvarande sätt arbetar delvis uppsökande och i nära samarbete med heldygnsvård och aktuell kommun/stad.

Uppföljning och utvärdering

Patienter med bipolär sjukdom kommer att återinsjukna i episoder av mani, hypomani, blandad episod eller depression. Det är av största vikt att dessa episoder behandlas så tidigt som möjligt för att begränsa sjukdomsförloppet och de långsiktiga konsekvenserna.

Vid tidiga tecken på begynnande episod (prodromer) kan det räcka med vid behovsmedicinering, egenvårdsåtgärder och beteendeinterventioner men vid begynnande eller pågående episod rekommenderas i första hand medicinsk behandling. Olika insatser behövs före, under och efter respektive episod. Se ovan Behandling för respektive episod.

NIVÅ 1

Stabila bipolära patienter som har erhållit episodförebyggande åtgärder inom specialistpsykiatrin och har en väl utarbetad krisplan kan följas upp i primärvården förutsatt att snabb uppföljning i specialistpsykiatrin kan erbjudas vid återinsjuknande. Tillgång till samverkan/konsultation med specialistläkare i psykiatri ska då erbjudas vid behov, till exempel vid medicinjustering. Patienter med litiumbehandling bör alltid följas upp av specialistpsykiatrin.

NIVÅ 2

Patienter som erhållit behandling vid episoder och episodförebyggande åtgärder kan behöva följas inom specialistpsykiatrin under lång tid, i vissa fall under hela patientens liv. Detta gäller särskilt då risken för nya allvarliga episoder är hög eller när den förebyggande farmakologiska behandlingen gör uppföljning i primärvården olämplig.

Vid god behandlingsrespons kan det gå mycket lång tid mellan episoderna men försämring kan trots detta komma mycket plötsligt. Uppföljningen består därför av både regelbundna kontroller och en beredskap för plötslig försämring.

Serumkoncentration

Beroende på patientens aktuella läkemedel genomför sjuksköterska provtagning enligt gällande riktlinjer för respektive läkemedel och mottagning (eller skickar remiss). För patienter som har underhållsbehandling med litium bör provtagning (S-Litium, Krea inklusive eGFR, TSH, T3, T4) ske var fjärde månad. Utebliven provtagning bör leda till utebliven receptförnyelse. Se även aktuell rutinprovsmall.

Årligt besök på mottagningen

Vid den årliga uppföljningen på mottagningen bör följande diskuteras med patienten:

- Antal och karaktär av depressiva och maniska/hypomana episoder samt heldygnsvård under senaste året jämfört med tidigare år.
- Aktuell symtombild.

- Aktuell psykosocial situation, sysselsättning och funktionsnivå.
- Följsamhet till läkemedelsbehandling och provtagningar.
- Läkemedelsbiverkningar.
- Behov av årlig hälsoundersökning via vårdcentral.
- Rutinprover för antipsykotiska läkemedel (när aktuellt).
- Behov av revidering av vårdplan, exempelvis läkemedelsjustering, repetition av psykoedukativa insatser, insatser till anhöriga/barn som anhöriga eller samverkan.
- Behov av revidering av krisplan utifrån nya episoder eller förändrade livsomständigheter.
- Utvärdering av behandling genom registrering i kvalitetsregistret BipoläR.

Akuta samtal vid tidiga tecken (prodromer) och symtom

Den bipolära patientens tillstånd kan snabbt skifta och det behöver finnas en beredskap för samtal och medicinjustering med kort varsel om patienten hör av sig till mottagningen på grund av tidiga tecken på begynnande episod (prodromer) eller symtom.

Att identifiera sådana och vid behov kontakta vården är något patienter lär sig i den episodförebyggande behandlingen och behöver sedan efterlevas både av patient och behandlare. På så sätt kan allvarliga episoder med stora konsekvenser både för patienten och sjukvården (inläggningar, kognitiv försämring, sänkt funktionsnivå och ökat vårdbehov över tid) i många fall undvikas helt eller åtminstone minimeras.

Före akuta samtal under uppföljning blir aktuella ska patienten sedan tidigare (se episodförebyggande åtgärder) ha upprättat en krisplan för tidiga tecken och symtom. Åtgärder som kan bli aktuella vid akuta samtal är:

- Riskbedömning och prevention vid förhöjd risk för självskada, suicid eller våld.
- Klargörande samtal över vad som kan ha utlöst tidiga tecken eller symtom.
- Stabilisering av rutiner vad gäller sömn, mat och aktivitet.
- Reducering av stimuli vid förhöjt stämningsläge och tidiga tecken på blandad episod, till exempel att avboka aktiviteter, undvika sociala medier, minska fysisk och sensorisk aktivitet och att undvika all form av alkohol, droger och andra stimulantia.
- Aktivering och minskat undvikande vid sänkt stämningsläge.
- Förslag på hantering av relationella problem eller av andra omgivningsspecifika sårbarhetsfaktorer i privatlivet eller på arbetet.
- Familje- eller närståendesamtal.
- Vid behovs-medicinering (om förskrivet) och/eller medicinjustering.
- Sjukskrivning.

NIVÅ 3

Ett fåtal patienter har på grund av kronisk instabilitet, frekventa inläggningar, hög risk och dåligt behandlingssvar och/eller följsamhet behov av mer omfattande, uppsökande och aktiva insatser från både specialistpsykiatri och kommun. I första hand rekommenderas då Assertive Community Treatment, ACT, eller Flexible Assertive Community Treatment, FACT, i andra hand vård i ett multiprofessionellt team med case management som på motsvarande sätt arbetar delvis uppsökande och i nära samarbete med heldygnsvård och aktuell kommun/stad.

Att beakta

Denna SVP tar inte specifikt upp de olika digitala lösningar för diagnostik och behandling som finns idag och som är under utveckling. Hit hör bland annat videotelefoni och videokonferenser/gruppbehandling genom molnbaserade IT-plattformar samt mobilapplikationer, kroppsnära teknik och maskininlärning där smartmobil kan användas både för diagnostik, monitorering och prevention av nya episoder (se till exempel Antosik-Wojcinska, 2020; Ortiz, 2021 samt Saccaro, 2021).

På sikt har e-hälsa potential både att göra evidensbaserad behandling mer tillgänglig för Skånes befolkning och befintliga behandlingar mer effektiva. Det saknas dock idag robust evidens för e-hälsolösningar vid bipolär sjukdom. Användningen bör därför ske aktsamt, utvärderas noggrant samt följa Region Skånes och Förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedels riktlinjer för digitala lösningar. För att kunna dra nytta av den utveckling som sker inom området e-hälsa för bipolär sjukdom är det samtidigt av hög vikt att Region Skåne följer utvecklingen, anpassar sitt regelverk och möjliggör integrering av lovande digitala lösningar i den framtida samlade digitala vårdmiljön (SDV).

Referenser

Adler, M. (2011). *Psykiatrisk diagnostik*. Lund: Studentlitteratur.

Adler, M. et al. (2014). *Bipolär sjukdom. Kliniska riktlinjer för utredning och behandling*. Svensk Psykiatri nr 14.

Adler, M. (2019). *Handbok i klinisk psykiatrisk diagnostik*. Stockholm: Psykiatriutveckling Sverige AB.

Antosik-Wójcińska, A. Z., Dominiak, M., Chojnacka, M., Kaczmarek-Majer, K., Opara, K. R., Radziszewska, W., Olwert, A., & Święcicki, Ł. (2020). Smartphone as a monitoring tool for bipolar disorder: a systematic review including data analysis, machine learning algorithms and predictive modelling. *International journal of medical informatics*, nr 138, s. 104-131.

Basco, M. R. & Rush, A. J. (2007). *Cognitive-behavioral therapy for bipolar disorder*. New York: Guilford Publications.

Bauer, M. & McBride, L. (2003). *Structured group psychotherapy for bipolar disorder: The life goals program*. New York: Springer publishing company.

Frank, E. (2007). *Treating bipolar disorder: A clinician's guide to interpersonal and social rhythm therapy*. New York: Guilford Publications.

Gitlin M. J. (2018). Antidepressants in bipolar depression: an enduring controversy. *International journal of bipolar disorders*, nr 6(1), s. 25ff.

Hansson, L., Lexén, A., & Holmén, J. (2017). The effectiveness of narrative enhancement and cognitive therapy: a randomized controlled study of a self-stigma intervention. *Social psychiatry and psychiatric epidemiology*, nr *52*(11), s. 1415–1423.

Holma, K. M., Haukka, J., Suominen, K., Valtonen, H. M., Mantere, O., Melartin, T. K., Sokero, T. P., Oquendo, M. A., & Isometsä, E. T. (2014). Differences in incidence of suicide attempts between bipolar I and II disorders and major depressive disorder. *Bipolar disorders*, nr 16(6), s. 652–661.

Lam, D. H., Jones, S. H. & Hayward, P. (2010). *Cognitive therapy for bipolar disorder*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc

Miklowitz, D. J., Frank, E., Jamison, K. R. & Kupfer, D. J. (2008). Bipolar disorder: A family-focused treatment approach. New York: Guilford Publications.

National institute for health and care excellence (2022). Bipolar disorder: assessment and management (CG185). *www.nice.org.uk/guidance/cg185*

Ortiz, A., Maslej, M. M., Husain, M. I., Daskalakis, Z. J., & Mulsant, B. H. (2021). Apps and gaps in bipolar disorder: A systematic review on electronic monitoring for episode prediction. *Journal of affective disorders*, nr 295, s. 1190–1200.

Paterniti, S., & Bisserbe, J. C. (2018). Factors associated with false positives in MDQ screening for bipolar disorder: Insight into the construct validity of the scale. *Journal of affective disorders*, nr 238, s. 79–86.

Regionalt vårdprogram bipolär sjukdom. (2017). Stockholms läns landsting.

Reinares, M. (2019). Psychotherapy for bipolar disorders: An integrative approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Saccaro, L. F., Amatori, G., Cappelli, A., Mazziotti, R., Dell'Osso, L., & Rutigliano, G. (2021). Portable technologies for digital phenotyping of bipolar disorder: A systematic review. *Journal of affective disorders*, nr 295, s. 323–338.

Wright, L., Lari, L., Iazzetta, S., Saettoni, M., & Gragnani, A. (2022). Differential diagnosis of borderline personality disorder and bipolar disorder: Self-concept, identity and self-esteem. *Clinical psychology & psychotherapy*, nr 29(1), s. 26–61.

Yanos, P. T., Roe, D., & Lysaker, P. H. (2011). Narrative enhancement and cognitive therapy: a new group-based treatment for internalized stigma among persons with severe mental illness. *International journal of group psychotherapy*, 61(4), 577–595.

Yanos, P. T., Lucksted, A., Drapalski, A. L., Roe, D., & Lysaker, P. (2015). Interventions targeting mental health self-stigma: A review and comparison. *Psychiatric rehabilitation journal*, nr 38(2), s. 171–178.

Yatham L. N. (2011). A clinical review of aripiprazole in bipolar depression and maintenance therapy of bipolar disorder. *Journal of affective disorders*, no. 128 supplement 1, s. 21–28.

Yatham, L. N., et al. (2018). Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. *Bipolar disorders*, nr *20*(2), s. 97–170.

Yatham, L. N et al. (2021). Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) recommendations for the management of patients with bipolar disorder with mixed presentations. *Bipolar disorders*, nr 23(8), s. 767–788.

Zimmerman, M., Galione, J. N., Ruggero, C. J., Chelminski, I., & Young, D. (2010). A different approach toward screening for bipolar disorder: the prototype matching method. *Comprehensive psychiatry*, nr 51(4), s. 340–346.

Åkerlund (2020). Vårdprocess bipolär sjukdom vuxenpsykiatri. Region Skåne, Psykiatri och habilitering.

Bilaga 1. Patientinformation

BEDÖMNING AV BIPOLÄR SJUKDOM

Dina besvär kan bero på bipolär sjukdom. Du har därför blivit erbjuden en bedömning som kan visa om du har en bipolär sjukdom eller inte.

Varför? Syftet med bedömningen är att du ska få en förklaring till dina besvär. Då kan du få veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig.

När? Det tar mellan ett och fyra besök att göra bedömningen. Väntetiden varierar.

Var? För det mesta görs bedömningen på samma ställe som du varit på tidigare men du kan få tider på en annan mottagning inom psykiatrin.

Vem? Du kan få träffa annan personal än tidigare när du gör en bedömning av bipolär sjukdom. Det är oftast en läkare, psykolog eller både och. Ta gärna med en närstående på besöken. Att ha med någon du känner kan vara ett bra stöd.

Hur? Informationen som framkommer i denna bedömning och i tidigare journalanteckningar vägs samman och analyseras av en läkare eller psykolog som ställer diagnos.

Självskattning

I samband med bedömningen kan du komma att få fylla i formulär där du värderar (skattar) dina besvär med hjälp av så kallade skattningsskalor.

Intervjuer

En viktig del av bedömningen består av en intervju. I den får du berätta om dina besvär och svara på frågor som utgår från dina självskattningar. Du får också frågor om din sjukdomshistoria. Syftet är att ta reda på vilka symtom du har, hur de utvecklats över tid och annat som kan påverka hur du mår. Det är också viktigt att ta reda på om du har problem i din vardag, exempelvis med relationer eller i ditt arbetsliv. Detta för att veta vilken typ av hjälp du behöver. Om det är möjligt vill vi intervjua någon som står dig nära. Närstående kan ofta bidra med viktig information om symtomen, hur de förändrats över tid och annat som kan vara bra för oss att känna till och som kan komplettera din berättelse.

Provtagning

Om du inte lämnat blodprov nyligen får du göra det. Blodprov tas eftersom vissa kroppsliga sjukdomar kan ge symtom som påminner om bipolär sjukdom. I utredningen ingår frågor om alkoholvanor och droger samt ett drogtest. Anledningen är att alkohol och droger kan göra att besvären blir värre och försvåra behandlingen.

Vad händer sen?

När bedömningen är färdig går vårdpersonalen igenom den tillsammans med dig. Om den visar att du har en bipolär sjukdom blir du erbjuden behandling. Bipolär sjukdom behandlas för det mesta med en kombination av läkemedel och patientutbildning. Även dina anhöriga

kan få utbildning om sjukdomen. Skulle bedömningen inte visa att du har bipolär sjukdom kan du få remiss till en vårdcentral för att få behandling för dina symtom där.

Om bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär oftast att vara manisk och deprimerad i perioder. Mellan perioderna brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt. Perioderna med depression eller mani kan vara olika långa och återkomma olika ofta. I vissa fall kan man ha en blandning av både maniska och depressiva symtom.

Vanliga symtom vid mani: minskat behov av sömn, ökad energi, upprymdhet, extremt stort självförtroende, att lätt bli irriterad, bete sig omdömeslöst och ta risker. Vid svår mani kan man ibland bli aggressiv.

Vanliga symtom vid depression: minskad energi, nedstämdhet, dålig självkänsla, problem med sömnen, kraftigt minskad eller ökad aptit, svårigheter att koncentrera sig, känslor av hopplöshet eller självmordstankar.

De vanligaste typerna av bipolär sjukdom:

Bipolär typ I innebär att man växlar mellan depression och mani. Under maniska perioder får en del även vanföreställningar eller tillfälliga psykoser. Diagnosen kallades tidigare för manodepressiv sjukdom.

Bipolär typ II är en mildare form av bipolär sjukdom då man växlar mellan depressioner och en mildare form av mani, så kallad hypomani. Bipolär sjukdom har man ofta hela livet men man kan vara symtomfri och leva som vanligt. Med åren brukar sjukdomen också bli lättare att hantera. Det beror ofta på att man har fått en behandling som fungerar samtidigt som man lärt sig hur man ska ta hand om sig själv för att minska symtomen.

Det här kan du göra själv

För dig som har en bipolär sjukdom är det extra viktigt att ta hand om din hälsa och inte stressa. Det kan göra att symtomen minskar och blir lättare att hantera.

- Regelbundna vanor hjälper. Att äta på samma tider samt att gå upp och gå och lägga sig ungefär samma tid varje dag är en bra grund.
- Att motionera är bra. Du kan till exempel promenera eller cykla. När du rör på dig bildas ämnen i kroppen som ger lugn och välbefinnande. Det blir också lättare att koncentrera sig.
- När du mår dåligt är det extra viktigt att du är försiktig eller slutar helt med alkohol och inte använder droger.

BEHANDLING AV BIPOLÄR SJUKDOM

Bipolär sjukdom behandlas framför allt med läkemedel och utbildning. Terapi och i vissa fall elbehandling kan också hjälpa. Du och vårdpersonalen kommer tillsammans fram till vad som passar bäst för dig.

Läkemedelsbehandling

Läkemedel är grunden i behandling av bipolär sjukdom. I första hand används läkemedel som är stämningsstabiliserande. De motverkar kraftiga svängningar i sinnesstämningen och minskar risken för att du ska bli sjuk. Man tar läkemedlet varje dag, ofta hela livet, även under perioder när man mår bra. Att förebygga nya perioder med depression eller mani är viktigt eftersom varje period innebär:

- lidande för dig och dina anhöriga
- påfrestning för hjärnan och risk för skador
- ökad risk för olycksfall och självmordsförsök
- risk för att sjukdomsperioderna blir tätare, längre och svårare att behandla.

Läkemedel för olika behov

I första hand rekommenderar vi behandling med litium, som är väl beprövat. Behandlas du med litium får du ta prover regelbundet för att se att koncentrationen av läkemedlet i blodet är lagom. Om litium inte passar dig finns andra alternativ. Ibland kan man behöva prova flera sorter innan man hittar den medicin som passar bäst. När du är i en manisk period får du ofta en kombination av läkemedel som är rogivande och stämningsstabiliserande. Har du en depression kan du behöva en medicin mot det. Under en period kanske du också behöver läkemedel mot sömnproblem eller ångest.

Patientutbildning

Våra mottagningar erbjuder utbildning om bipolär sjukdom, så kallad psykoedukation, för dig och dina närstående. Här får man bland annat lära sig vad bipolär sjukdom är och vad man själv och ens närstående kan göra för att minska risken för nya episoder.

Elbehandling

Elbehandling (ECT) är en vanlig behandling vid perioder med svår depression. Behandlingen kan ge ett snabbare resultat än läkemedel. Skulle det bli aktuellt för dig får du mer information av din läkare.

Mer hjälp

Närstående kan vara ett stöd

Det är bra att informera och involvera dina närstående i behandlingen. Om du berättar hur du mår blir det lättare för dem att vara ett stöd för dig.

Dagliga rutiner

- Motion är bra mot depression. Om du behöver hjälp att komma i gång kan du få ett recept på fysisk aktivitet.
- Prata med din behandlare om du behöver stöd och råd när det gäller matvanor, sömn och att skapa rutiner i vardagen. Om du har svåra sömnproblem kan till exempel sömnskola och tyngdtäcke hjälpa dig.

- Om du jobbar skift eller natt kan du behöva ändra dina arbetstider. Prata med din läkare och arbetsgivare om det.

Heldygnsvård

Ibland blir en sjukdomsperiod så svår att det är nödvändigt att bli inlagd på en avdelning. Där finns personal som kan hjälpa dig när det känns extra svårt. Om du behöver det kan läkarna snabbt ändra din behandling. Närstående får gärna besöka dig om du vill.

Viktigt med krisplan

Tillsammans med din behandlare och dina närstående får du göra en krisplan där ni listar tidiga tecken på din sjukdom. Planen ska också innehålla information om vad du och dina närstående ska göra och vart ni ska vända er för att få hjälp. Sätt gärna upp krisplanen på insidan av en garderobsdörr eller någon annanstans där den är lätt att hitta.

Vad händer sen?

Du och vårdpersonalen gör tillsammans regelbundna uppföljningar av din behandling. Om behandlingen behöver ändras får du och din behandlare diskutera det. Du kan också behöva utredas för andra problem. Har du en bipolär sjukdom typ 1 eller behandlas med litium behåller du kontakten med oss i psykiatrin. Andra bipolära sjukdomar behandlas vanligen på en vårdcentral när man mår bättre.

Bilaga 2. Litiumbehandling

Litiumbehandling

Litiumpreparat	Litiumsulfat (depot)- Lithionit®, 6 mmol Litiumkarbonat (ej depot)- 8 mmol, licenspreparat Litiumcitrat (depot)- Litarex®, 6 mmol, licenspreparat, finns även som mixtur
Före insättning	Ta Hb, vita, glukos, HbA1c, kreatinin inkl eGFR, Na, K, Calciumjon, TSH, T3, T4, urinsticka, vikt, längd och blodtryck. EKG. Iohexolclearance vid misstanke om njursjukdom.
Insättning	Vanlig startdos är 1+1, eventuellt i en dos på kvällen. Ta s-li dag 5–7 för dosjustering. Följ s-li en gång per vecka tills tre stabila värden på avsedd nivå. Det finns ett linjärt samband mellan dos och koncentration. S-li ska tas 12 timmar efter senaste dos! Rekommenderad koncentration: 0,5–0,9 mmol/l. Vid akut mani rekommenderas snabb upptitrering till 0,8–1,2 mmol/l med koncentrationsbestämning varannan eller var tredje dag. Litiumclearance avtar med åldern vilket innebär att lägre doser behöver ges till äldre. Koncentrationen bör ligga i den nedre delen av det terapeutiska intervallet.
Monitorering	s-li, kreatinin inkl eGFR, TSH, T3, T4 var fjärde månad. Na, K, Calciumjon, HbA1c, vikt, och blodtryck en gång per år.
Vanliga biverkningar	Tremor. Kan avta. Är ofta dosberoende. Eventuellt behandling med låg dos av betablockerare. Diarré. Kan bli bättre om litium ges direkt efter maten. Eventuellt byte till behandling med litiumkarbonat eller litiumnitrat. Ökad urinmängd. Mät urindygnsmängd. Polyuri= över tre liter/dygn. Amilorid kan eventuellt provas för att minska urinmängden. S-li påverkas vanligen ej men bör kontrolleras efter insättning. Viktuppgång. Kost- och motionsråd är viktigt! Hypothyreos. Är vanligt, kan komma snabbt och till och med det första året. Behandling med Levaxin vid långsamt utvecklande stigande TSH, annars remiss endokrinolog. Acne. Förvärrad psoriasis. Hudläkarkonsult. Kognitiva och emotionella biverkningar. Överväg annan orsak till exempel depression. Sänk eventuellt dosen. Håravfall. Prova att sänka dosen. Hyperparathyreoidism. Mycket ovanligt men förekommer efter mångårig behandling. Vid förhöjd Calciumjon tag om s-Ca. Om fortsatt förhöjt värde remittera till endokrinolog. Njurpåverkan. Minskad tubulär funktion är vanlig på grund av hämmat återupptag av vatten vilket ger polyuri, se ovan. Denna är som regel reversibel. Glomerulusskador är ovanliga vid normala litiumkoncentrationer. Intoxikationer eller långtidsbehandling ökar risken något. Om eGFR sjunker >20 procent av utgångsvärdet bör kontakt tas med njurmedicinsk konsult.
Patient-information	Eftersom litium har ett snävt terapeutiskt intervall är det viktigt med noggrann information till patienten om behandlingen, särskilt om interaktioner med NSAID och blodtrycksmedicin.

Intoxikation Litiumbehandling (kontakta invärtesmedicinsk konsult vid tecken på intoxikation)

Intoxikation	S-li >1,5 mmol/l: lindrig/måttlig intoxikation. S-li >2,5 mmol/l: allvarlig intoxikation > 3mmol/l: livshotande
Riskfaktorer	Sänkt njurfunktion, dehydrering, överdos.
Tidiga symtom	Diarré, dysartri, ataxi, tremor
Utvecklad intoxikation	Konfusion, kramper, njurskador, hjärtrytmrubbningar, koma.
Interaktion	Antiinflammatoriska läkemedel, tiaziddiuretika, vissa hypertonimediciner ökar koncentrationen av litium. Kolla FASS!
Patient-information	Informera om risk för intoxikation vid hög feber, vätskeförlust i samband med diarré, kräkningar eller hög värme. Vid svårare dehydrering bör litium sättas ut tillfälligt under några dagar. Även viktigt att informera patienten och personal inför operation.